

# FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

## ESCALA DE CALIDAD DE VIDA EN LA ESQUIZOFRENIA (QLS)

Eje IV: Calidad de Vida y Funcionamiento • Evaluación Semiestructurada del Síndrome Deficitario

### 1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

|                                 |                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre Oficial (Español)</b> | Escala de Calidad de Vida en la Esquizofrenia (QLS).                                       |
| <b>Nombre Original</b>          | Quality of Life Scale (QLS; Heinrichs, Hanlon & Carpenter, 1984).                          |
| <b>Autores Originales</b>       | Douglas W. Heinrichs, M.D., Thomas E. Hanlon, Ph.D. y William T. Carpenter Jr., M.D.       |
| <b>Adaptación Hispana</b>       | Rodríguez et al. (1995); Bobes, García-Portilla, Bascarán, Sáiz et al. (2007); CIBERSAM.   |
| <b>Eje Clínico y Constructo</b> | Eje IV: Funcionamiento y Calidad de Vida. Impacto del síndrome deficitario esquizofrénico. |
| <b>Tipo de Instrumento</b>      | Entrevista clínica semiestructurada heteroaplicada por profesional entrenado.              |
| <b>Formato y Reactivos</b>      | 21 reactivos calificados con anclajes conductuales operativos de 7 puntos (0 a 6).         |
| <b>Población y Rango</b>        | Adultos ( $\geq 18$ años) con diagnóstico de esquizofrenia o trastorno esquizoafectivo.    |
| <b>Tiempo de Administración</b> | 30 a 45 minutos de entrevista clínica detallada con paciente y allegados.                  |
| <b>Régimen de Licencia</b>      | Uso clínico y académico abierto bajo citación formal / Maryland Psychiatric Research Ctr.  |

### 2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL: EL SÍNDROME DEFICITARIO COMO DETERMINANTE VITAL

La **QLS** fue concebida en el **Maryland Psychiatric Research Center** (Heinrichs, Hanlon & Carpenter, 1984) con la premisa metodológica de que las escalas tradicionales (BPRS, PANSS) medían predominantemente síntomas positivos floridos (delirios, alucinaciones), dejando sin evaluar el **síndrome deficitario** primario e intrínseco de la esquizofrenia:

- El Defecto Esquizofrénico:** La merma en la calidad de vida no deriva primordialmente de las ideas delirantes, sino de la abulia, la anhedonia social, el aplanamiento afectivo y la desorganización instrumental que paralizan la vida comunitaria.
- Juicio Clínico Experto:** A diferencia de los autoinformes (vulnerables a la falta de conciencia de enfermedad / anosognosia), la QLS exige que el clínico interrogue sobre conductas observables objetivas de las últimas 4 semanas y evalúe la capacidad volitiva real del paciente.
- Operacionalización de Anclajes:** Cada uno de los 7 niveles por reactivo dispone de descripciones clínicas exhaustivas para garantizar máxima reproducibilidad interjueces.

### 3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE FACTORES (21 ÍTEMS)

La estructura factorial del QLS se compone de 4 dimensiones clínicamente operativas:

| Dimensión / Factor                    | Ítems QLS           | Contenido y Conductas Evaluadas                                                    |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Relaciones Interpersonales</b>  | Ítems 1 al 8        | Vínculos íntimos, relaciones con amigos, redes sociales, evitación sociosexual.    |
| <b>2. Rol Instrumental</b>            | Ítems 9 al 11       | Ocupación laboral o académica, grado de productividad y satisfacción con el rol.   |
| <b>3. Fundamentos Intrap-síquicos</b> | Ítems 13-17, 20, 21 | Motivación intrínseca, anhedonia, curiosidad vital, propósito vital y empatía.     |
| <b>4. Objetos y Actividades</b>       | Ítems 18 y 19       | Posesión y uso de objetos comunes cotidianos y participación activa en ocio.       |
| <b>Ítem Global Autocontenido</b>      | Ítem 12             | Juicio subjetivo global de satisfacción vital (se integra en la puntuación total). |

## PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y BAREMACIÓN CLÍNICA

### 4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO PSICOMÉTRICO EN ESPAÑA / LATAM

La adaptación española de Rodríguez et al. (1995) y las validaciones multicéntricas de Bobes et al. (2007) acreditan propiedades psicométricas de referencia internacional:

| Propiedad Psicométrica       | Coefficiente / Métrica  | Interpretación Metodológica y Evidencia Empírica                                  |
|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Consistencia Interna Total   | Alfa de Cronbach = 0.92 | Alta coherencia factorial global; factores específicos oscilan entre 0.82 y 0.89. |
| Concordancia Interexaminador | CCI = 0.87 - 0.94       | Elevadísima reproducibilidad diagnóstica entre clínicos con entrenamiento básico. |
| Estabilidad Test-Retest      | CCI = 0.85 - 0.91       | Excelente confiabilidad a 4 semanas en pacientes crónicos estabilizados.          |
| Validez de Criterio Negativa | r = -0.68 (PANSS-N)     | Fuerte correlación inversa con la subescala de síntomas negativos de la PANSS.    |
| Sensibilidad Longitudinal    | Efecto d = 0.72         | Sensible a intervenciones psicosociales integrales y antipsicóticos atípicos.     |

### 5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

- **Marco Temporal:** Se evalúa el funcionamiento del paciente en las últimas 4 semanas previas a la entrevista.
- **Escala de Respuesta:** Cada uno de los 21 reactivos se califica en una escala ordinal de 7 niveles (0 a 6):
  - *Puntuación 0 o 1:* Disfunción grave o ausencia casi total de la conducta.
  - *Puntuación 2 o 3:* Alteración moderada con déficit funcional notable.
  - *Puntuación 4 o 5:* Adecuación funcional con dificultades mínimas o esporádicas.
  - *Puntuación 6:* Funcionamiento plenamente adaptativo, normal o excelente.
- **Puntuación Total QLS:** Suma de las calificaciones en los 21 reactivos:

$$\text{Puntuación Total QLS} = \sum_{i=1}^{21} \text{Ítem}_i \quad (\text{Rango: 0 a 126 puntos})$$

- **Direccionalidad Clínica:** A diferencia de las escalas sintomáticas, **a mayor puntuación, MEJOR calidad de vida** y mayor preservación de la funcionalidad comunitaria.

### 6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN FUNCIONAL

| Estratificación    | Rango QLS    | Severidad Deficitaria | Estado Funcional y Nivel de Integración                                |
|--------------------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Deterioro Severo   | 0 a 35 pts   | Defecto Marcado       | Colapso funcional; aislamiento total, abulia grave, nula ocupación.    |
| Deterioro Moderado | 36 a 65 pts  | Defecto Moderado      | Red social precaria; incapacidad para sostener empleo competitivo.     |
| Deterioro Leve     | 66 a 95 pts  | Defecto Mínimo        | Vida comunitaria aceptable; apoyo familiar suficiente; tareas básicas. |
| Funcional / Normal | 96 a 126 pts | Remisión Funcional    | Integración social activa, autonomía personal y ocupación sostenida.   |

**CRITERIO DE REMISIÓN CLÍNICO-FUNCIONAL EN ESQUIZOFRENIA (QLS ≥ 66):** El consenso internacional de recuperación funcional en psicosis exige superar los **66 puntos** en la QLS (media de 3.1 por ítem). Una puntuación inferior a 45 tras remisión de síntomas positivos indica presencia de **síndrome deficitario persistente** que requiere rehabilitación psicosocial específica.

## APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

### 7. ALGORITMO DE SEGUIMIENTO EN REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL DE PSICOSIS

**PROTOCOLO DE REHABILITACIÓN CON MONITORIZACIÓN QLS:** • **Paso 1 (Fase Post-Brote / Estabilización):** Aplicar QLS a las 4-6 semanas del alta hospitalaria; identificar áreas factoriales más comprometidas (generalmente Rol Instrumental y Fundamentos Intrapsíquicos). • **Paso 2 (Estratificación de Intervenciones):** - *Factor Interpersonal* < 15: Derivar a Entrenamiento en Habilidades Sociales y grupos terapéuticos comunitarios. - *Factor Instrumental* < 6: Derivar a Centro de Rehabilitación Laboral / Talleres Ocupacionales adaptados. • **Paso 3 (Monitorización Semestral):** Evaluar ganancia neta. Un incremento de  $\geq 15$  puntos globales representa una mejoría funcional clínicamente relevante. • **Paso 4 (Detección de Apatía Secundaria):** Si la subescala de fundamentos intrapsíquicos decae bruscamente, descartar parkinsonismo farmacológico inducido por antipsicóticos.

### 8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: RECONEXIÓN SOCIAL Y LABORAL EN ESQUIZOFRENIA RESIDUAL

**Identificación:** Varón de 28 años, con diagnóstico de Esquizofrenia Paranoide desde hace 4 años, sin alucinaciones ni delirios activos bajo pauta de Paliperidona depot. Sin embargo, pasa el día encerrado en su habitación, sin amigos y con abandono de sus estudios de formación técnica. **Evaluación Inicial QLS (Heteroaplicada):** • **Puntuación Total QLS = 31 / 126 puntos (Deterioro Deficitario Severo).** • *Desglose Factorial:* Relaciones Interpersonales = 7/48; Rol Instrumental = 2/18; Fundamentos Intrapsíquicos = 14/42; Objetos/Actividades = 5/12; Satisfacción Global = 3/6. **Intervención Multimodal:** Se incorporó a Centro de Día, iniciando Terapia Cognitivo-Conductual para síntomas negativos, Entrenamiento en Habilidades Sociales y Club Social de ocio tutelado. Paralelamente, se ajustó la medicación para minimizar sedación diurna. **Reevaluación a los 9 Meses:** La Puntuación Total QLS ascendió a **72 / 126 puntos (Deterioro Leve / Integración Favorable).** El paciente consolidó un grupo de pares de ocio semanal, retomó un curso de capacitación informática con asistencia del 90% y manifestó satisfacción con su autonomía cotidiana.

### 9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

**DEFECTO VS. DEPRESIÓN POST-BROTE:** Una caída selectiva en satisfacción global (ítem 12) acompañada de disforia sugiere depresión post-esquizofrénica con alto riesgo autolítico, no síndrome deficitario puro.

**HETEROPERCEPCIÓN OBLIGATORIA:** Nunca autoadministrar la QLS; los pacientes con anosognosia grave puntúan erróneamente en el rango normal omitiendo su aislamiento objetivo y déficit habitacional.

### 10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Heinrichs, D. W., Hanlon, T. E., & Carpenter, W. T. (1984). The Quality of Life Scale: An instrument for rating the schizophrenic deficit syndrome. *Schizophrenia Bulletin*, 10(3), 388-398.
2. Rodríguez, A., et al. (1995). Adaptación española de la escala de calidad de vida en la esquizofrenia (QLS). *Archivos de Neurobiología*, 58(4), 163-172.
3. Bobes, J., García-Portilla, M. P., Bascarán, M. T., Sáiz, P. A., & Bousoño, M. (2007). Banco de instrumentos básicos para la práctica de la psiquiatría clínica (4ª ed.). *Psiquiatría Editores*.
4. Carpenter, W. T., Heinrichs, D. W., & Wagman, A. M. (1988). Deficit and nondeficit forms of schizophrenia: The concept. *American Journal of Psychiatry*, 145(5), 578-583.